

DIGITALISERING IN DE ZORG



‘Transformatieplan Coalitie Digitalisering – ’t Gezond Gooi’

Van: E.F.B. Melger, E. Vosmeijer, A. Borst, M. Jaring, A. Kivits en B. van Vliet.

Versie 0.6 – Augustus 2025



Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
1 Achtergrond en Introductie.....	6
1.1 Regionale urgentie en context.....	6
1.2 Probleemstelling	6
1.3 Ambitie van de coalitie Digitalisering	7
1.4 Positionering binnen IZA en landelijke kaders	8
2 Doelen en resultaten.....	9
2.1 Digitalisering & gegevensuitwisseling.....	9
2.2 Netwerk Informatie Systeem.....	9
2.3 Inrichten van DSO en aansluiten op RSO.....	10
2.3.1 Werkagenda	11
3 Roadmap2023.....	12
3.1 Fase Ontwikkelen & Selecteren periode Q1 en Q2 2025	12
3.2 Fase Ontwikkelen & Selecteren periode Q3 en Q4 2025	12
3.3 Fase Uitbreiden & Opschalen periode Q1 en Q2 2026	13
3.4 Fase Uitbreiden & Opschalen periode Q3 2026 – eind 2030	14
4 Business case, impact & maatschappelijke business case.	14
4.1 Impactanalyse	14
4.2 Verwachte effecten	14
4.3 Businesscase en baten	15
5 KPI's, monitoring & bijsturing	18
5.1 Opzet en fasering.....	18
5.2 Tabel 2: KPI-overzicht (zie excel bijlage):	19
5.3 Monitoring & bijsturing	19
6 Risicomanagement.....	20
6.1 Risico's en mitigerende maatregelen	20
6.2 Risico overzicht	20
6.3 Structurele bekostiging na afloop transformatiefase.....	21
7 Referenties.....	22

Leeswijzer

Dit transformatieplan is opgesteld in het kader van de IZA-transformatiegelden en beschrijft de gezamenlijke aanpak van de Coalitie Digitalisering in regio 't Gooi. Digitalisering is essentieel voor alle beoogde transformaties en bij het creëren van een meer patiëntgerichte, efficiënte en toekomstbestendige zorg. De coalitie Digitalisering is opgericht als fundament voor de vijf andere coalities binnen Gezond Gooi, en richt zich op het verbeteren van gegevensbeschikbaarheid en communicatie tussen professionals en inwoners.

Als regio pakken we dit gezamenlijk aan omdat uniforme digitalisering leidt tot een betere coördinatie van zorg en een gelijke toegang tot het aanbod voor alle inwoners. Dit omvat het inzetten van technologie en digitale systemen met als doel zorgprocessen te optimaliseren, gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en om innovatieve zorgmodellen te ondersteunen. Dit doen wij door te focussen op een digitaal platform met zelfhulp aanbod, gegevensuitwisseling, inzicht in het zorg en ondersteuningsaanbod, en hybride zorgmodellen.

Het plan richt zich op het verenigen van de regionale partijen binnen Gezond Gooi in een Digitale Samenwerkings Organisatie (DSO) die aan is gesloten op een Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO) en het creëren van een digitaliseringsprogramma om de gezamenlijke infrastructuur, gegevensuitwisseling, applicaties en IZA opgaven te realiseren.

De ambitie is om de inwoner centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken door middel van digitale klantreizen, gegevensuitwisseling en netwerkzorg. Dit plan is integraal opgenomen in de strategieën van alle coalities en dient als basis voor de komende jaren, waarin stapsgewijs wordt gewerkt aan implementatie, opschaling en borging.

Het document bestaat uit twee delen:

1. De kern: dit is het ingevulde IZA-indieningsformaat met de hoofdlijnen van de transformatie.
2. Verdieping: een inhoudelijke uitwerking van de aanpak, governance, impact, KPI's, en financiering en risico's. Deze verdieping is gebaseerd op regionale analyses, usecases en afspraken met coalitiepartners.

In het eerste hoofdstuk worden de achtergrond, probleemstelling en doelstellingen van de transformatie uiteengezet. Vervolgens worden in hoofdstuk twee de doelen en resultaten beschreven, die in hoofdstuk 3 in een roadmap zijn vertaald. Hoofdstuk vier

en verder gaan in op de impact, de business case met KPI's, gevolgd door de governance en risicobeheersing.

1 Achtergrond en Introductie

1.1 Regionale urgentie en context

De regio Gooi en Vechtstreek kampt met een toenemende zorgvraag ten gevolge van; vergrijzing van de bevolking, hoog aandeel eenzaamheid, invloed van bestaansonzekerheid, ongezonde levenswijzen, levenswijzen, overconsumptie, toename mentale problematiek, tendens van labelen en medicaliseren, omgaan met onbegrepen gedrag van kinderen, hoog midden middelengebruik onder jongeren en volwassenen toegang en toename van zorg thuis, zodat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegenover deze stijging in de zorgvraag staat een afname van het zorgaanbod ten gevolge van arbeidsmarktkrapte in zorg en ondersteuning, halvering mantelzorg potentieel, lange wachttijden gebrek aan domein overstijgende samenwerking en onvoldoende door- en uitstroom. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk.



1.2 Probleemstelling

De huidige zorgstructuur in 't Gooi is onvoldoende toegerust om de groeiende complexere zorgaanvraag op te vangen. De verschillende domeinen hebben zich georganiseerd in het samenwerkingsnetwerk Gooi en Vechtstreek. Het netwerk, en de beweging, is in gang gezet. Echter, er is behoefte aan een formelere organisatie met bijbehorende afspraken.

Op het gebied van digitale samenwerking is sprake van de volgende problemen:

1. Er vindt beperkte digitale uitwisseling plaats, en het ontbreekt aan een gezamenlijke architectuur en digitale infrastructuur.
2. Er is geen project of programmaorganisatie om de gemeenschappelijke regionale doelstellingen, architecturen en applicaties te realiseren.

3. Er zijn beperkte digitale en veranderkundige vaardigheden in de context van de complexe opgaven.

Bovenstaande knelpunten leiden tot vertraging in zorgtoeleiding, inefficiënt gebruik van middelen en verminderde toegankelijkheid voor inwoners. De urgentie wordt gedeeld door zorgaanbieders, gemeenten, en zorgverzekeraars.

1.3 Ambitie van de coalitie Digitalisering

Digitalisering en gegevensuitwisseling zijn een belangrijk fundament voor Gezond Gooi om haar doelstellingen te halen. De ambitie van de coalitie Digitalisering is om direct bij te dragen aan de transformatiedoelen om het zorggebruik te verminderen en het arbeidstekort te verkleinen. De coalitie zet in op generieke verbeteringen, zoals:

1. Het beschikbaar stellen van gegevens via een regionale architectuur
2. Het implementeren van landelijke standaarden en infrastructuur
3. Het realiseren van een Netwerk Informatie Systeem (NIS) en VIPLive-platform
4. Het ondersteunen van klantreizen met digitale modules en koppelingen tussen systemen.

De kosten om deze ambitie te realiseren zijn opgenomen in dit transformatieplan, alsook de baten. Als baten ziet de coalitie het beschikbaar zijn van actuele patiëntgegevens die niet telkens opnieuw verzameld hoeven te worden, een betere communicatie tussen professionals en inwoners door het beschikken over dezelfde informatie, en het feit dat organisaties binnen Gezond Gooi profiteren van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling zonder telkens zelf nieuwe oplossingen te hoeven ontwikkelen. Deze baten zijn in het transformatieplan beschreven en verder uitgewerkt in de businesscase en bijbehorende KPI's.

De coalitie Digitalisering draagt bij aan het realiseren van de transformatiedoelen van de inhoudelijke coalities¹ van Gezond Gooi door de generieke verbeteringen passend te maken voor meerdere klantreizen. De klantreizen (ook wel usecases) beschrijven de nieuwe manier van samenwerken tussen de verschillende domeinen binnen Gezond Gooi, de afspraken die daarbij horen, de informatie die uitgewisseld wordt en de (functionele) eisen aan systemen. De generieke verbeteringen worden gespecificeerd per klantreis. Hierdoor worden ook baten behaald die de kwaliteit van zorg verhogen, wat bijvoorbeeld resulteert in kortere doorlooptijden of gerichter verwijzen. Deze baten worden niet opgenomen in dit transformatieplan.

¹ De inhoudelijke coalities van Gezond Gooi zijn Waardig Ouder Worden, Mentale Gezondheid, Gezond Leven en Preventie, Ketensamenwerking, Wijkgericht Werken en Acute Zorg.

De coalitie Digitalisering is faciliterend en de inhoudelijke coalities zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop de klantreizen worden ingericht. De coalitie Digitalisering faciliteert de inrichting van deze klantreizen technisch en organisatorisch. De werkafspraken tussen de coalitie Digitalisering en de inhoudelijke coalities worden vastgelegd.

1.4 Positionering binnen IZA en landelijke kaders

Alle activiteiten in dit transformatieplan sluiten aan bij de landelijke en regionale IZA-thema's, zijnde:

1. Passende zorg
2. Regionale samenwerking
3. Versterking eerstelijnszorg
4. Digitalisatie en databeschikbaarheid
5. Samenwerking met het sociaal domein
6. Gezond leven en preventie

Het plan is afgestemd op het regiobeeld Gooi en Vechtstreek, de ROAZ-plannen en de visie op eerstelijnszorg 2030.

Het transformatieplan is in lijn met de Nationale Visie en Strategie (NVS) en het uitvoeringsakkoord IZA, waarin keuzes zijn gemaakt op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling. De NVS geeft een beschrijving van drie plateau's die moeten leiden tot landelijke databeschikbaarheid in 2035. In het uitvoeringsakkoord IZA wordt aangegeven welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van gemeenschappelijke voorzieningen, het naleven van normen voor informatiebeveiliging, en het volgen van standaarden voor specifieke vormen van gegevensuitwisseling zoals medicatieoverdracht en e-overdracht.

De coalitie werkt in de regio samen in de Digitale Samenwerkingsorganisatie (DSO), en is in voorbereiding op aansluiten op een Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO).

Daarnaast neemt de regio Gezond Gooi deel aan het landelijke programma Boooot. Dit programma richt zich op het op orde brengen van de basis voor digitalisering en gegevensuitwisseling binnen de regio. Boooot faciliteert organisaties bij het voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging en ondersteunt aansluiting op landelijke voorzieningen, zoals Mitz voor toestemmingsregistratie en ZORG-AB voor adressering. Het programma Boooot wordt extern uitgevoerd; de bijbehorende kosten en baten maken dan ook geen onderdeel uit van dit transformatieplan. Wel realiseert het programma essentiële randvoorwaarden om gegevensuitwisseling op een veilige en efficiënte wijze mogelijk te maken.

2 Doelen en resultaten

2.1 Digitalisering & gegevensuitwisseling

Het transformatieplan Digitalisering richt zich op het verminderen van het zorggebruik en het verkleinen van het arbeidstekort. In dit kader wordt ingezet op het verbeteren van digitale samenwerking en gegevensuitwisseling binnen het zorgdomein en tussen het zorg- en sociaal domein. Er wordt gewerkt aan de DSO/RSO en de selectie en implementatie van het Netwerk Informatie Systeem als basis voor samenwerking en gegevensuitwisseling.

2.2 Netwerk Informatie Systeem

De transformatie binnen Gezond Gooi richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen organisaties en professionals, organisatie-overstijgende informatievoorziening, en regie door patiënten en inwoners. In aanvulling op paragraaf 1.2 is gegevensuitwisseling tussen organisaties echter niet vanzelfsprekend en worden dossiers op dit moment gefragmenteerd bijgehouden in verschillende bronsystemen.

De coalitie Digitalisering ziet de inzet van een Netwerk Informatie Systeem (NIS) als een belangrijke eerste stap. Begin 2025 is gestart met het selectieproces van leveranciers om te bepalen welk NIS het meest geschikt is voor de regio. Tijdens dit proces zijn zowel de inhoudelijke coalities als de professionals betrokken, waarbij breed draagvlak als voorwaarde gold. Eind Q1 2025 is op basis van deze procedure gekozen voor VIPLive als voorkeurs-NIS.

Vanaf het tweede kwartaal van 2025 worden, wederom in nauwe samenwerking met de inhoudelijke coalities, vier klantreizen beproeft² in VIPLive. Hiermee kan aan het eind van 2025 een gefundeerde go/no-go beslissing voor VIPLive worden genomen. In 2026 volgt de implementatie van VIPLive, te beginnen met deze vier klantreizen. Vervolgens wordt het systeem verder uitgebreid met meerdere klantreizen en opgeschaald door aansluiting van meer organisaties en professionals.

De kern van het NIS is het ondersteunen van domein overstijgende klantreizen. Het NIS VIPLive maakt op korte termijn het volgende mogelijk:

² De uitwerking van het beproeven, inclusief een standaard manier van werken voor alle toekomstige klantreizen, staat in de bijlagen.

- *Multidisciplinaire consultatie*

Digitale ondersteuning van overleg tussen professionals, leidt tot betere triage en minder vervolgsconsulten. Het NIS reduceert overlegmomenten door direct beschikbare relevante informatie per case.

- *Dossierinzage en netwerkdossiervoering*

Verbeterde coördinatie en reductie van acute zorg door proactieve planning. Mogelijkheid tot tijdig anticiperen. Inhoudelijke afstemming wordt efficiënter door real-time beschikbare informatie.

- *Domein overstijgende verwijzingen*

Vermindering van administratieve lasten door éénmalige, direct inzichtelijke registraties en betere opvolging van verwijzingen door inzicht in context via NIS.

- *Inzicht aanbod van zorg en ondersteuning*

Efficiëntere verwijzing naar passende zorg, vermindering van onnodige inzet van BGGZ en wijkverpleging door beschikbaarheid van overzicht van zorgverleners, inclusief wachttijden/lijsten via VIPLive/NIS koppeling met Steunwijzer.

- *Proactieve zorgplanning*

Digitale vastlegging van wensen en behoeften, leidt tot reductie van ongewenste palliatieve zorg en betere ketensamenwerking. Het NIS zorgt voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze informatie over de hele zorgketen per case.

Het NIS voldoet aan ISO27001, NEN7510 en AVG, en is ontwikkeld volgens privacy-by-design-principes. Het ondersteunt zowel professionals als inwoners, en is te koppelen aan bestaande bronsystemen via Single Sign-On en API's.

2.3 Inrichten van DSO en aansluiten op RSO

Voor effectieve digitale samenwerking en een veilige, betrouwbare gegevensuitwisseling is het essentieel om een passende organisatievorm op te zetten die deze processen faciliteert binnen Gezond Gooi. Gedurende de uitvoering van het transformatieplan, en in de daaropvolgende beheerfase, dienen onderwerpen zoals beheer, contract- en leveranciersmanagement en gebruikersondersteuning zorgvuldig te worden vastgelegd en geborgd.

Voor dit doel wordt een organisatiestructuur opgezet die samenwerking tussen zorginstellingen, verschillende domeinen en de ondersteuningsorganisatie binnen Gezond Gooi mogelijk maakt. Dit krijgt vorm als de Digitale Samenwerkingsorganisatie

Gezond Gooi (DSO), waarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Er wordt onderzocht op welke wijze deze rollen, taken en verantwoordelijkheden van de DSO kunnen worden ondergebracht bij een RSO.

Een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) fungeert als gezamenlijk opdrachtnemer en biedt executiekracht, expertise, een digitale agenda, implementatiebegeleiding, gezamenlijke architectuur en de uitvoering van het regio brede digitaliseringsprogramma gedurende 2025-2027. De RSO realiseert hierbij de gestelde doelstellingen, implementeert gezamenlijke applicaties en faciliteert digitale gegevensuitwisseling. Tevens ondersteunt de organisatie hybride zorgprocessen die samenwerking vereisen, en draagt bij aan de realisatie van landelijke standaarden, basisinfrastructuur en gegevensuitwisselingen.

2.3.1 Werkagenda

De landelijke richtlijnen, zoals vastgelegd in het uitvoeringsakkoord IZA en de NVS, worden binnen de regio geïmplementeerd ter bevordering van digitale samenwerking. De coalitie Digitalisering heeft een werkagenda opgesteld waarin zowel landelijke als regionale prioriteiten zijn opgenomen die de komende jaren gerealiseerd zullen worden. Door deelname van Gezond Gooi aan het programma Boooot worden de landelijke thema's uit de werkagenda door Boooot regionaal doorgevoerd. De werkagenda biedt richting en ondersteunt bij het stellen van prioriteiten en het maken van weloverwogen keuzes.

Bij het maken van keuzes hanteert de coalitie de volgende uitgangspunten:

- We sluiten aan op landelijke ontwikkelingen,
- We weten wat werkt in andere regio's,
- We kopiëren met trots wat er al is,
- We zetten daarbij in op opschalen.
- Zo zorgen we dat er niks bijkomt!

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt en opgenomen in de regionale architectuur van Gezond Gooi. De architectuur biedt kaders voor de samenwerking door richting te geven aan de regionale infrastructuur.

3 Roadmap2023

De transformatie op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling is gestart en wordt gefaseerd uitgevoerd tot 2030. In de volgende paragrafen wordt de gefaseerde aanpak toegelicht, van uitgevoerde activiteiten tot nog uit te voeren activiteiten. Er worden drie periodes onderscheiden: ontwikkelen & selecteren, ontwikkelen & beproeven, en uitbreiden & opschalen. Elke fase bevat specifieke activiteiten die zijn gericht op de uitvoering van het programma, en bijdragen aan de beschreven doelen en resultaten.

Let wel, er zijn operationele en bestuurlijke afhankelijkheden tussen activiteiten. De roadmap maakt schuiven mogelijk zodat alle activiteiten goed op elkaar afgestemd blijven.

3.1 Fase Ontwikkelen & Selecteren periode Q1 en Q2 2025

Netwerk Informatie Systeem

Aan het begin van 2025 is besloten een selectietraject te starten om de diverse NIS-systemen met elkaar te vergelijken en te beoordelen op geschiktheid voor de regio Gezond Gooi. Dit traject heeft geresulteerd in de keuze voor VIPLive.

Inrichten van DSO en aansluiten op RSO

De werkagenda is in samenwerking met het programma Booozt opgesteld. Deze werkagenda dient als sturingsinstrument en benoemt de beoogde resultaten voor 2025. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking binnen de coalitie Digitalisering, en er ligt een contract voor de beproevingsfase van VIPLive met een financiële verdeling als er geen goedgekeurd transformatieplan is. De keuze voor vier klantreizen om te gaan beproeven is gemaakt in samenspraak met de inhoudelijke coalities.

Tot slot is in de eerste helft van 2025 is samen met de regio Gezond Gooi een regionale architectuur ontwikkeld, gebaseerd op voorbeelden uit andere regio's.

3.2 Fase Ontwikkelen & Selecteren periode Q3 en Q4 2025

Netwerk Informatie Systeem

In de tweede helft van 2025 worden voor VIPLive de vier klantreizen uitgewerkt in gedetailleerde plannen van aanpak, voorzien van duidelijke criteria om aan het einde van 2025 een goed onderbouwd go/no-go-besluit voor te leggen aan het bestuur van de coalitie. De regio Gezond Gooi wordt zorgvuldig betrokken via diverse overlegorganen.

De vier klantreizen worden getest om te beoordelen of ze de samenwerking ondersteunen. De criteria worden geëvalueerd en de conclusie wordt vastgelegd. In december volgt een go/nogo-besluit.

De structuur van het meerjarencontract voor VIPLive wordt opgesteld, bij voorkeur door een groter team, om de contractborging in de regio te waarborgen. Hierdoor is het noodzakelijk om een beheerorganisatie voor VIPLive op regionaal niveau op te zetten; de rollen, taken en verantwoordelijkheden worden ondergebracht bij de DSO.

Daarnaast wordt een eerste ontwerp voor de implementatie van VIPLive opgesteld. Een zorgvuldige afstemming met diverse ICT-afdelingen binnen de organisaties van Gezond Gooi is hierbij van groot belang. Tevens worden aspecten als de impact op het sociaal domein, de prioritering van het uitrollen van klantreizen en de integratie met bronsystemen meegenomen in de overwegingen.

Inrichten van DSO en aansluiten op RSO

De DSO is feitelijk al in werking doordat de coalitie Digitalisering samenwerkt. Een aantal rollen, taken en verantwoordelijkheden worden formeler belegd, zodat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze rollen en taken kunnen overgedragen worden aan een RSO.

De architectuur dient vastgesteld te worden door het bestuur van de coalitie.

3.3 Fase Uitbreiden & Opschalen periode Q1 en Q2 2026

Netwerk Informatie Systeem

De implementatie van VIPLive start bij een go in 2026. Het implementatieplan wordt aangescherpt en formeel vastgesteld. De projectorganisatie is volledig voorbereid; afstemming met inhoudelijke coalities en ICT organisaties vindt structureel plaats. Toekomstig op te pakken klantreizen zijn geïnventariseerd, evenals koppelingen met bronsystemen. De manier van werken is bepaald.

De vier beproefde klantreizen worden als eerste uitgerold; meerdere organisaties gaan werken volgens de beproefde klantreizen.

Het is van belang te benadrukken dat goedkeuring voor VIPLive aan het einde van 2025 als randvoorwaarde geldt, evenals het afsluiten van een meerjarencontract. De financiële verdeling dient binnen iedere organisatie te zijn goedgekeurd. Tevens is het noodzakelijk dat de uit te voeren activiteiten zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.

Inrichten van DSO en aansluiten op RSO

De DSO wordt verder ingericht, ook voor het beheer van VIPLive. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden worden verder beschreven. De omschrijving van deze rollen en taken vindt plaats vanuit het perspectief van informatiemanagement, waarbij aandacht wordt besteed aan de strategische, tactische en operationele niveaus, ook wel richtinggevende, sturende en uitvoerende lagen genoemd.

Het toepassen van rollen en taken maakt het mogelijk dat wie het invult hiervan in de loop van de tijd kan veranderen of verschillen tussen implementatie en beheer.

Het aansluiten op een RSO wordt onderzocht, inclusief tijdspad, zodat een besluit kan worden genomen.

De werkagenda is in uitvoering.

3.4 Fase Uitbreiden & Opschalen periode Q3 2026 – eind 2030

De werkwijze om klantreizen door te voeren is geïmplementeerd binnen Gezond Gooi; Gezond Gooi functioneert als een goed op elkaar afgestemd team. Deze aanpak vormt nu de standaard onder de verantwoordelijkheid van DSO/RSO.

4 Business case, impact & maatschappelijke business case.

4.1 Impactanalyse

De beoogde impact van de doelen en resultaten opgenomen in dit transformatieplan is op verminderen van het zorggebruik en het verkleinen van het arbeidstekort.

De impact analyse is zowel kwalitatief als kwantitatief onderbouwd en richt zich op generieke verbeteringen in zorggebruik, samenwerking, personeel en toegankelijkheid.

De bijbehorende baten zijn uitgewerkt in deze business case en de KPI's. De baten als gevolg van het bijdragen aan de realisatie van de transformatiedoelen van de inhoudelijke coalities³ van Gezond Gooi door de generieke verbeteringen passend te maken voor meerdere klantreizen, zijn niet opgenomen (zie ook paragraaf 1.3).

4.2 Verwachte effecten

Aspect	Impact kwalitatief	1e lijn (huisartsen)	VVT	2e lijn (zknhzn)	GGZ	Sociaal Domein
Zorggebruik	Verbetering van triage en verwijsgedrag, reductie van	V	V	V	V	V

³ De inhoudelijke coalities van Gezond Gooi zijn Waardig Ouder Worden, Mentale Gezondheid, Gezond Leven en Preventie, Ketensamenwerking, Wijkgericht Werken en Acute Zorg.

	onnodige consulten en opnames, betere doorstroom tussen domeinen.					
Personeel	Vrijspelen van FTE door digitale ondersteuning, vermindering van administratieve lasten, betere inzet van schaarse capaciteit.	V	V	V	V	V
Vastgoed	Optimalisatie van gebruik door hybride zorgvormen en betere afstemming van voorzieningen	V	V	V	V	V
Toegankelijkheid	Verbetering van wachttijdinzicht, dossierinzage en overdracht via VIPLive en NIS	V	V	V	V	V
Samenwerking	Versterking van domeinoverstijgende samenwerking door uniforme digitale processen en governance	V	V	V	V	V

4.3 Businesscase en baten

De businesscase van de coalitie Digitalisering is gebaseerd op de investeringen in infrastructuur, koppelingen, training en ondersteuning. Daarnaast zijn de kosten voor de aanvraag van de IZA “snelle toets” digitalisering opgenomen en de kosten voor het aanhaken van het sociaal domein. Volgens de business case is er sprake van:

- De gemaakte aanloopkosten en kosten voor de projectleiders digitale coalitie gedurende 2025 tot en met 2027.
- De gemaakte kosten voor de IZA aanvraag
- De gemaakte kosten voor de NIS selectie en de contractering.
- Kassiersfunctie t.b.v. het sociaal domein en de overige partijen.
- De overkoepelende projectleider voor de NIS implementatie.

- De kosten voor het inrichten, implementeren van het NIS met de generieke voorzieningen en 9 klantreizen.
- De kosten voor 50 koppelingen met domein specifieke applicaties zijn opgenomen.
- De generieke voorzieningen hebben de potentie voor een structurele besparing van €10,2 miljoen aan zorgkosten tot en met 2030.
- Na 2029 is door de realisatie een besparing van 3 miljoen per jaar mogelijk
- De baten van de klantreizen niet opgenomen in deze businesscase zoals beschreven in paragraaf 1.3
- De generieke voorzieningen hebben de potentie voor het vrijspelen van 18 FTE aan personele inzet vanaf 2029.

Business Case								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Realisatie	€ 10.185.963		€ -	€ 659.217	€ 1.291.634	€ 2.004.317	€ 3.019.909	€ 3.210.885
Kosten	€ 9.920.433		€ 996.766	€ 5.295.522	€ 2.525.460	€ 360.308	€ 367.514	€ 374.864
Resultaat	€ 265.529		€ -996.766	€ -4.636.305	€ -1.233.826	€ 1.644.009	€ 2.652.395	€ 2.836.021
Resultaat cumulatief			€ -996.766	€ -5.633.071	€ -6.866.896	€ -5.222.887	€ -2.570.492	€ 265.529
Realisatie								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Netwerk-Informatiesysteem	€ 10.185.963		€ -	€ 659.217	€ 1.291.634	€ 2.004.317	€ 3.019.909	€ 3.210.885
Totaal per jaar			€ -	€ 659.217	€ 1.291.634	€ 2.004.317	€ 3.019.909	€ 3.210.885
Cumulatief	€ 10.185.963		€ -	€ 659.217	€ 1.950.851	€ 3.955.169	€ 6.975.077	€ 10.185.963
Kosten								
		In %	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personele Kosten								
Interne personeelskosten	€ 5.921.422	67,2%	€ 289.072	€ 3.641.215	€ 1.991.134			
Externe inhuur	€ 930.545	10,6%	€ 506.574	€ 163.146	€ 260.825			
Materiële kosten								
Interne doorbelastingen	€ 23.837	0,3%	€ 11.250	€ 7.905	€ 4.682			
Frictie leercurve / key-users	€ -	0,0%						
Externe aankopen								
Opleidingskosten	€ -	0,0%						
Aanschaf IT	€ 1.111.800	12,6%		€ 1.111.800				
Frictie IT	€ 742.840	8,4%	€ 180.000	€ 319.025	€ 243.814	€ 360.308	€ 367.514	€ 374.864
Totaal	€ 8.730.443		€ 986.897	€ 5.243.092	€ 2.500.455	€ 360.308	€ 367.514	€ 374.864
1% onvoorzien	€ 87.304	1,0%	€ 9.869	€ 52.431	€ 25.005	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 8.817.748	100,0%	€ 996.766	€ 5.295.522	€ 2.525.460	€ 360.308	€ 367.514	€ 374.864

De volgende aannames zijn gehanteerd:

- Er is gerekend met een blended tarief, gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de functies in de regio
- De functies in de regio, de uurtarieven, de aantallen en de besparing door het gebruik van de generieke voorzieningen zijn gebaseerd op beschikbare informatie (zie hiervoor het tab-blad “bronnen”)

- De frictie IT kosten zijn gebaseerd op de inclusie percentages van de zorgprofessionals (zie tab blad “BC uitwerking”)
- De kosten worden jaarlijks geïndexeerd met 2%
- Trainingen is als kostenpost opgenomen, gebaseerd op 2000 professionals in de regio Gezond Gooi. Deze post is inclusief verlet-uren
- De nul-meting voor de twee resultaat KPI's wordt als eerste uitgevoerd, zodat een realistisch beeld van de KPI's kan worden bepaald.

5 KPI's, monitoring & bijsturing

5.1 Opzet en fasering

De KPI's zijn verdeeld over drie fasen, conform het IZA-beoordelingskader:

- Ontwikkeling: vaststellen van werkwijzen, governance en technische randvoorwaarden.
- Invoering: implementatie van digitale modules, koppelingen en klantreizen.
- Uitvoering: structurele toepassing in het primaire proces en monitoring van effecten.

Per fase zijn KPI's opgesteld die gekoppeld zijn aan de uitbetaling van transformatiemiddelen. De verdeling is:

- 70% inspannings-KPI's: gekoppeld aan concrete deliverables zoals contacten, notities, functionele eisen
- 30% resultaat KPI's: gekoppeld aan meetbare effecten zoals wachttijdreductie, verwijsgedrag, gebruik van VIPLIVE.

Onderstaande KPI's (Tabel 2) zijn geformuleerd op basis van het beoordelingsverslag van Zilveren Kruis en voldoen aan SMART-criteria:

5.2 Tabel 2: KPI-overzicht (zie excel bijlage):

Type	Onderdeel	KPI	Deliverable	2025	2025	2025	###	2027	Meetmethode				
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Inspanning KPI	NIS	Selecteren van een NIS-leverancier.		x								Opleveren van het BO besluit.	
	NIS	Selecteren van 4 klantreizen.			x							Opleveren van het BO besluit.	
	NIS	Uitwerken van de klantreizen inclusief selectiecriteria voorfase van beproeven..				x						Opleveren van plannen.	
	NIS	Opstellen van het implementatieplan					x	x				Opleveren van een implementatieplan.	
	NIS	Implementatie van de vier klantreizen	Klantreizen 1 t/m 4 live met NIS					x	x			Eind q4-2026 500 actieve gebruikers Viplive	
	NIS	Uitwerken klantreizen 5 en 6 & 7,8 en 9.							x	x		Opleveren van plannen.	
	NIS	Beproeven klantreizen 5 en 6 & 7,8 en 9.								x	x	Akkoord op de klantreizen	
	NIS	Implementeren van de klantreizen 5,6,7,8 en 9.	Klantreizen 5 t/m 9 live met NIS								x	x	Eind q4-2027 1,00 actieve gebruikers Viplive
	NIS	Vervolg bepalen klantreizen 10 en verder.	Regionale werkagenda.									x	Opnemen in de regionale werkagenda.
	NIS	Meerjarencontract afsluiten met leverancier.	Getekend contract				x	x					Contract afgesloten.
	DSO	DSO ingeregeld.	De programmastructuur voor de realisatie van het transformatieplan is ingericht en goedgekeurd binnen het		x								Functioneren BO-digitalisering als overlegstructuur DSO.
	DSO	DSO verder professionaliseren.				x	x	x	x				Aanscherpen rollen, taken en verantwoordelijkheden.
	DSO	Onderzoek aansluiten op RSO met besluitvorming.						x	x				Besluit vastgesteld bestuurlijk platform Gezond Gooi.
DSO	Aansluiten bij een RSO	RSO ondertekend overdracht							x			Keuze RSO.	
DSO	Werkagenda landelijke en regionale prioriteiten vastgesteld.			x								Opleveren van de werkagenda	
Resultaat KPI													
		Verkleinen van het arbeidstekort door de tijdsbesparing van de inzet van Viplive	Besparing in het aantal minuten per zorgprofessional.									x Uitvoeren 0 meting. Vaststellen KPI in minuten. Vaststellen van het resultaat.	
		Zorggebruik verminderen.	Zorgverbruik per inwoner daalt.									x Uitvoeren 0 meting. Vaststellen KPI in euro's per inwoner. Vaststellen van het resultaat.	

5.3 Monitoring & bijsturing

- Frequentie: kwartaalrapportages vanaf start implementatiefase
- Verantwoordelijke: programmamanager en kernteam
- Gebruik: input voor bestuurlijk overleg, evaluatie en bijsturing
- Tooling: waar mogelijk gebruik van bestaande systemen (VIPLive, NIS)

Monitoring heeft een dubbele functie:

1. Verantwoording behaalde KPI's en uitbetaling IZA-transformatiegelden.
2. Interne sturing op voortgang en effectiviteit van de transformatie binnen de regio.

Het streven is dat de monitoring zo'n klein mogelijke (administratieve) inspanning vergt van betrokken organisaties. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande tooling.

6 Risicomanagement

6.1 Risico's en mitigerende maatregelen

Eens succesvolle digitale transformatie vereist niet allen visie en middelen, maar ook een scherp inzicht in potentiële risico's en een robuuste strategie om deze te beheersen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's benoemd die de uitvoering van het transformatieplan kunnen beïnvloeden, inclusief mitigerende maatregelen, prioritering en escalatielijnen (hoofdstuk 6). De risicoanalyse is gebaseerd op de oorspronkelijke planinhoud.

6.2 Risico overzicht

Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel	Escalatielijn	Prioriteit
Onvoldoende draagvlak bij deelnemende organisaties (m.n. gemeente)	Gemiddeld	Hoog	Realistischere fasering met tijdige communicatie, bestuurlijke afstemming	Programmamanager → stuurgroep	Hoog
Financiële risico's bij tegenvallende baten of cofinanciering	Hoog	Hoog	Periodieke update businesscase, signalering bij afwijking	Stuurgroep → BO IZA	Hoog
Capaciteitstekort voor uitvoering digitale ondersteuning (bv. Verkennend gesprek)	Gemiddeld	Hoog	Vroegtijdige planning, commitment en contractuele borging	Projectleider → coalitieoverleg	Hoog
Lage adoptie van NIS onder zorgprofessionals ondanks actualiteit	Gemiddeld	Hoog	Inzet van ambassadeurs via VIPLive academie	Programmamanager → communicatieteam	Middel
Geen Mandaat vanuit achterban domeinen	Laag	Hoog	Regelmatige afstemming met domeinvertegenwoordigers	Stuurgroep → BO IZA	Middel
Onvoorzienbare (externe) omstandigheden	Laag	Hoog	Flexibel/agile plan met herverdeling capaciteit	Programmamanager → stuurgroep	Middel
Dubbelingen met andere coalities	Laag	Middel	Regionale afstemming en gezamenlijke doelstellingen	Coalitieoverleg → regioteam	Laag

**Onvoldoende
technische
interoperabiliteit met
bronsystemen**

Middel

Middel

Vroegtijdige toetsing,
inzet
architectuurprincipes

Architect → kernteam

Middel

6.3 Structurele bekostiging na afloop transformatiefase

De structurele bekostiging van activiteiten en digitale infrastructuur na afloop van de transformatiefase worden bij voorkeur geborgd via reguliere financieringsstromen binnen de Zvw, Wmo en gemeentelijke contractering. De coalitie hanteert hierbij de volgende uitgangspunten.

- De zorgactiviteiten: de activiteiten zoals verkennende gesprekken, digitale overdracht en domein overstijgende verwijzingen worden structureel opgenomen in reguliere contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De inhoudelijk coalities zijn verantwoordelijk voor het borgen van deze activiteiten in hun contractafspraken.
- Digitale infrastructuur: VIPLive en het NIS worden structureel bekostigd via meerjarencontracten met de financiers. De kosten worden verdeeld over deelnemende organisaties op basis van gebruik, functionaliteit en technische koppelingen. Er wordt gewerkt met een exploitatiemodel waarin licenties, beheer en doorontwikkeling zijn opgenomen.
- Beheer en ondersteuning: Functioneel beheer, helpdesk, scholing en monitoring worden opgenomen in de reguliere exploitatie van deelnemende organisaties. De uitwerking, inclusief financiële afspraken, volgt.
- Monitoring en dataverwerking: Monitoring van gebruik, KPI's en impact wordt geïntegreerd in bestaande informatiestromen en verantwoordingsstructuren. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande tooling (zoals VIPLive en dashboards) om administratieve lasten te beperken. Tevens wordt samengewerkt met de werkgroep monitoring van Gezond Gooi om overlap en dubbelop te voorkomen.
- Aansluiting bij DSO en Booozt: De structurele bekostiging sluit aan bij de DSO en het Booozt- programma. De coalitie Digitalisering werkt samen met andere regio's en RSO's om schaalvoordelen en interoperabiliteit te realiseren
- Documentatie en borging: de structurele bekostiging wordt vastgelegd in:

De structurele bekostiging wordt vastgelegd in de DSO:

- Meerjaren-contract met NIS leverancier (Q4 2025)
- Bijbehorende financiële verdeelsleutel Gezond Gooi (Q4 2025)

- Gezond Gooi Beheerorganisatie uitwerken en vaststellen; rollen, taken en verantwoordelijkheden, contractbeheer, financieel management, leveranciersmanagement, etc. (Q2 2026)
- Onderlinge afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars over doorfinanciering (Q1 2026)

7 Referenties

1. Gemiddelde wachttijd specialistische GGZ (RIVM) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (z.d.). *Gemiddelde wachttijd specialistische GGZ: Volwassenen* [Gegevensrapport]. Geraadpleegd op [12/08/2025], via https://www.rivm.nl/mentale-gezondheid/monitor/gevolgen-mentale-ongezondheid/wachttijden_specialistische_GGZ
2. Wachttijden geestelijke gezondheidszorg (VZinfo) VZinfo. (2025, 25 maart). *Wachttijden | Geestelijke gezondheidszorg*. Geraadpleegd op [12/08/2025], via <https://www.vzinfo.nl/wachttijden/geestelijke-gezondheidszorg>
3. Regiobeeld 't Gooi (Integraal Zorgakkoord) Gezond Gooi (2023, 28 juni). *Regiobeeld 2023 Gooi en Vechtstreek: Integraal Zorgakkoord* [PDF-bestand]. Geraadpleegd op [12/08/2025], via <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2023/09/Regiobeeld-t-Gooi.pdf>

Bijlage 1:

Organisatie & Werkwijze

De governance van de Coalitie Digitalisering is opgebouwd uit drie niveaus:

- Strategisch niveau: bestuurlijk overleg tussen coalities binnen Gezond Gooi, inclusief besluitvorming over contractering, verdeelsleutels en architectuur.
- Tactisch niveau: programmamanager en kernteam sturen op uitvoering van de werkagenda, budgetten en bemensing. Rapportage vindt plaats aan het bestuurlijk overleg.
- Operationeel niveau: projectleiders, domeinvertegenwoordigers en IT-specialisten werken aan inrichting van klantenreizen, koppeling en proeftuinen.

Rollen en verantwoordelijkheden

Rol	Verantwoordelijkheden
Programmamanager	Centrale spil, verantwoordelijk voor voortgang, rapportage en afstemming met coalities
Projectleiders	Implementatie VIPLive Per klantenreis of module, verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering
Architecten	Inrichting van de regionale architectuur en koppelingen
Functioneel en technisch beheerders	Implementatie en beheer van VIPLive en NIS
Domeinvertegenwoordigers	Input vanuit GGZ, VVT, Sociaal domein, huisartsen en gemeenten
Stakeholders	Management, communicatie, klantcontact – bepalen eisen en prioriteiten

RACI-Matrix voor governance en besluitvorming

Categorie	Toelichting	Wie
Rollen	Wie voert uit? Adviseert? Beslist?	Programmamanager, projectleiders,

		domeinvertegenwoordigers, leveranciers
Aanspreekpunten	Wie is aanspreekbaar op voortgang, inhoud en financiën?	Programmamanager (tactisch), stuurgroep (strategisch), projectleiders (operationeel)
Keuzes	Wie neemt besluiten over architectuur, verdeelsleutel en klantenreizen?	Stuurgroep (strategisch), kernteam (tactisch), coalitieoverleg (inhoudelijk)
Informatie	Wie ontvangt welke informatie en via welk kanaal?	Bestuurlijk overleg (notulen), coalitiepartners (dashboard), financiers (kwartaalrapportage)

Escalatieprotocol: besluitvorming bij afwijkingen

Om de voortgang en kwaliteit van de transformatie te waarborgen, is een helder escalatieprotocol ingericht. Dit protocol beschrijft hoe afwijkingen van planning, budget, draagvlak of inhoudelijke afspraken worden gesignaleerd beoordeeld en opgelost.

Drempelwaarden voor escalatie

Categorie	Drempelwaarde	Signaalgever
Planning	>1 maand vertraging op kritieke mijlpaal	Projectleider
Budget	>10% overschrijding op kwartaalbudget	Programmamanager
Draagvlak	>2 deelnemende organisaties trekken zich terug	Stuurgroep
Inhoud	Kritieke functionaliteit niet haalbaar binnen scope	Architect/Functioneel beheerder
Governance	Besluitvorming stagneert >2 weken	Programmamanager

Escalatielijnen

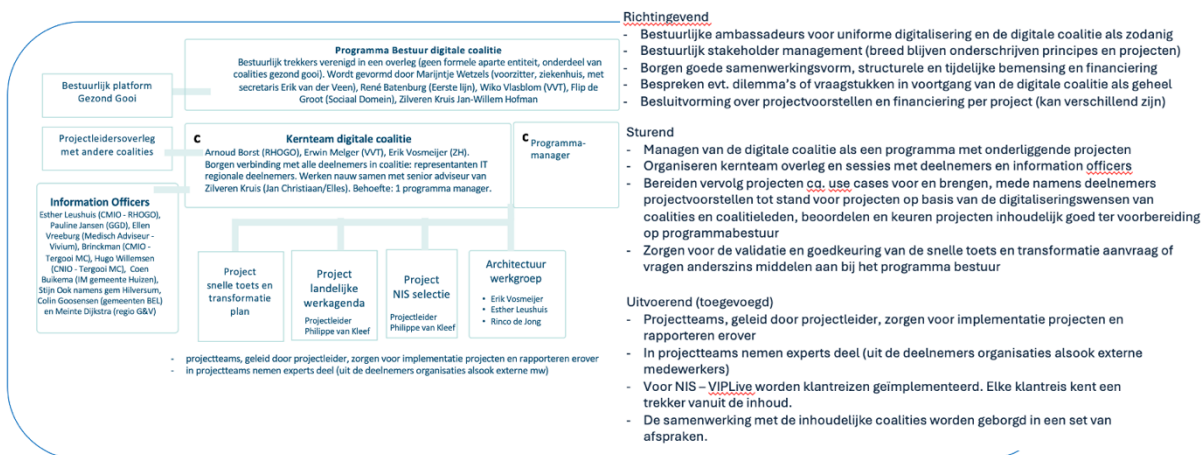
Niveau	Situatie	Actie
Operationeel	Dagelijkse uitvoering, kleine afwijkingen	Projectleider lost op binnen team

Tactisch	Structurele afwijking in planning, budget of samenwerking	Programmanager bespreekt in kernteam en rapporteert aan stuurgroep
Strategisch	Impact op coalitie brede afspraken, contractering of financiering	Stuurgroep beslist, eventueel opschaling naar BO IZA of regioteam

Organogram

Samenwerkingsvorm en afspraken Coalitie Digitalisering

We vormen een digitale samenwerkingsorganisatie met een programma bestuur en een kernteam
Advies om gelet op de meerjarige werkagenda vaste regionale digitale programmamanager in en voor gezond gooi te werven



Figuur: Organisatie coalitie Digitalisering met rollen, taken en verantwoordelijkheden, inclusief relatie netwerk Gezond Gooi.

Werkwijze coalitie-overstijgend

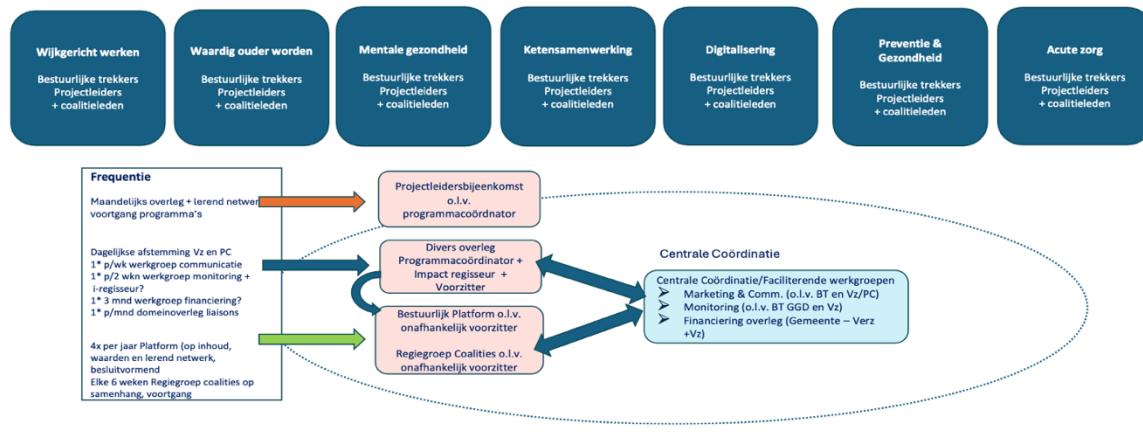
De Coalitie Digitalisering werkt samen met de inhoudelijke coalities. Per klantreis worden afspraken gemaakt over:

- Rollen en taken bij inrichting en uitvoering;
- Ureninzet en verdeling van kosten en baten;
- Functionele eisen aan digitale modules;
- Gebruik van AI voor wachttijdinzicht en dataverwerking;
- Scholing en communicatie richting professionals en inwoners.

De coalitie Digitalisering is verantwoordelijk voor technische implementatie, communicatie en ondersteuning. De inhoudelijke coalities leveren professionals en input voor proeftuinen.

Afspraken samenhang Gezond Gooi

Bijlage 2. Gezond Gooi samenwerkingsstructuur, licht en (gelijk)gericht
(tijdelijke versterking coördinatie en functionele lijn naar faciliterende werkgroepen)



Beheer en borging

Tijdens de fase van beproeven en de start van de implementatie wordt de beheerorganisatie verder ingericht. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden worden verder beschreven. De omschrijving van deze rollen en taken vindt plaats vanuit het perspectief van informatiemanagement, waarbij aandacht wordt besteed aan de strategische, tactische en operationele niveaus, ook wel richtinggevend, sturende en uitvoerende lagen genoemd.

Het toepassen van rollen en taken maakt het mogelijk dat wie het invult hiervan in de loop van de tijd kan veranderen of verschillen tussen implementatie en beheer.

Het aansluiten op een RSO wordt onderzocht, inclusief tijdspad, zodat een besluit kan worden genomen.

Taken zijn o.a.

- Functioneel beheer van VIPLive en NIS;
- Ondersteuning bij gebruik en adoptie;
- Monitoring van gebruikservaring en feedback;
- Bijsturing op basis van KPI's en evaluaties.

Bijlage 2:

Werkwijze - Inrichting van klantreizen

De inrichting van klantreizen is een verantwoordelijkheid van de inhoudelijke coalities binnen Gezond Gooi, zijnde Waardig Ouder Worden, Mentaal Gezondheidsnetwerk, Gezond Leven en Preventie, Netwerksamenwerking en Wijkgericht Werken.

De coalitie Digitalisering vervult hierin een faciliterende rol door het beschikbaar stellen van digitale infrastructuur, koppelingen en ondersteuning. Elke klantreis wordt ingericht volgens een stapsgewijze aanpak, waarbij de coalitie Digitalisering ondersteuning biedt op de volgende onderdelen:

1. Technische ondersteuning bij het vaststellen van klantenreizen
 - a. Digitalisering levert tooling en dashboards om inzicht te geven in het procesverloop.
2. Digitale ondersteuning bij het opstellen van functionele eisen
 - a. Coalities bepalen de inhoud, Digitalisering vertaalt dit naar technische specificaties.
3. Selectie en inrichting van modules van VIPLive
 - a. Configuratie op basis van functionele behoefte inhoudelijke coalities.
4. Koppelingen en integratie
 - a. Realisatie van koppelingen met bronssystemen en autorisatiemodellen.
5. Testen in proeftuinen
 - a. Digitalisering faciliteert testomgevingen en feedbackloops.
6. Evaluatie en verbetering
 - a. Monitoring via dashboards, input voor doorontwikkeling.
7. Opschaling bij positieve beoordeling
 - a. Coalities besluiten over opschaling, Digitalisering ondersteunt technisch
8. Opleveren van documentatie, met onder andere
 - a. De huidige en toekomstige situatie (ist & soll)
 - b. De rollen, taken en verantwoordelijkheden

- c. De verantwoordelijkheden voor de waarde creatie en kritische performance indicatoren (KPI's) als onderdeel van de acceptatiecriteria.

De afspraken over rollen, ureninzet en financiering worden per werkgroep vastgelegd, in samenspraak met de inhoudelijke coalitie. De coalitie Digitalisering is verantwoordelijk voor de technische implementatie, communicatie en scholing, maar niet voor de inhoudelijke inrichting van klantreizen

Governance en beheer

Tijdens de implementatie worden rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd, waaronder:

- Projectleider klantreis
- Procesexpert
- Functioneel beheerder
- IT-specialist
- Eindgebruikers/testers
- Stakeholders (management, communicatie, klantcontact)

Beheer en support worden georganiseerd via VIPLive Academie en een centrale helpdesk. Feedback wordt structureel verzameld en verwerkt.